

37. EL CEREBRO PRÁCTICO

DURACIÓN : 13:08

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo, "El Cerebro Práctico", presenta un enfoque biodinámico detallado centrado en el cerebro y su expansión. El instructor enseña cómo identificar los niveles de expansión en el paciente, explorando estrategias de redinamización eficaces, como el trabajo sobre el corazón y los ejes digestivos. A continuación, se explora los movimientos de flexión cefálica y pontina, con precauciones específicas a tomar durante el tacto. Al centrarse en la sensación de expansión, los profesionales aprenderán a acompañar el movimiento de encefalización, comprendiendo el ritmo y la sincronización ligados a la embriología biodinámica. Esta sesión es a la vez teórica y práctica, prometiendo a los estudiantes una comprensión enriquecida y habilidades desarrolladas para mejorar su práctica.

37. EL CEREBRO PRÁCTICO: ENFOQUE BIODINÁMICO

I. POSICIONAMIENTO INICIAL Y BÚSQUEDA DE LA EXPANSIÓN

Me posiciono por encima del paciente, específicamente a nivel de la **ínsula**. Mis manos se colocan aquí, mis pulgares se cruzan ligeramente, y me aseguro de tener un buen punto de apoyo para mis codos y muñecas en la camilla.

El **tacto** es extremadamente suave. Busco sentir la **expansión** del campo.

A. IDENTIFICAR LA FALTA DE EXPANSIÓN

Lo primero que hay que evaluar es el nivel de **expansión**. Si la expansión es insuficiente y no me siento lo suficientemente "empujado", es una señal de que algo no está bien.

A menudo, se espera una expansión inmediata y fuerte, pero no siempre es el caso.

B. ESTRATEGIAS DE REDINAMIZACIÓN EN CASO DE FALTA DE EXPANSIÓN

Si la expansión es insuficiente, se deben explorar varias vías para **redinamizar** el sistema:

- **El corazón:** Aligerar el corazón suele ser un enfoque muy eficaz.

- **Los ejes digestivos:** Trabajar sobre los ejes digestivos (mesentéricos, mesentéricos) o el eje celíaco puede proporcionar la expansión necesaria.
- **El sacro y los pedículos:** Subir hasta el sacro y los niveles pediculares también puede ayudar.

En general, trabajar con el corazón o los ejes digestivos permite obtener resultados más rápidos y eficaces.

II. EL MOVIMIENTO DE FLEXIÓN Y LA ENCEFALIZACIÓN

Una vez que la expansión está presente, siento una expansión seguida de un movimiento de **flexión** hacia adelante. Es la flexión cefálica, que lleva el cerebro hacia el corazón.

Detrás, debo percibir un movimiento de **flexión cervical**. Si siento un ligero déficit a este nivel, indica la necesidad de una corrección cervical o estructural.

A. LA FLEXIÓN PONTINA Y LA TELENCEFALIZACIÓN

Luego me concentro en mis dedos meñiques y busco la **flexión pontina**. El movimiento desciende.

Luego, aparece una nueva expansión. En esta etapa, puedo abrir mi mano. Es el comienzo del proceso de **telencefalización**, que se recupera del nivel occipital al nivel temporal.

B. ERRORES COMUNES Y PRECAUCIONES

La mayoría de los errores ocurren cuando se toca directamente el cerebro. Es imperativo no tocar el cerebro si no se está "bajo esa frecuencia".

- Me posiciono por encima, sin tocar con mis pulgares, manteniendo una buena distancia.
- Creo un **fulcro** muy suave con mis pulgares y un punto de apoyo importante.

C. LA SENSACIÓN DE EXPANSIÓN

Una buena expansión se siente como un plano de calor y una sensación de empuje suave.

III. EL MOVIMIENTO SECUENCIAL Y EL ACOMPAÑAMIENTO

Realizo un movimiento muy suave. Todavía no es mi "H-puente insular". Hago el movimiento de flexión hacia adelante. El movimiento desciende bien, pero puede desviarse ligeramente en torsión (por ejemplo, hacia la izquierda). Acompaño muy ligeramente esta torsión.

En esta etapa, puede ser necesaria una pequeña corrección, potencialmente a nivel cardíaco. Puede haber un momento en que el movimiento no sea perfecto, pero no es grave.

A. DESCENSO DE LA FLEXIÓN Y PLANO PONTINO

Luego me dirijo hacia el descenso de la flexión, que el paciente debe sentir distintamente. Desciende sin problema.

Una vez establecido esto, paso al **plano pontino**. Aquí también, puede ser necesaria una pequeña intervención.

B. EL PLANO TELENCEFÁLICO Y LA EXPANSIÓN ASCENDENTE

Después del plano pontino, vuelvo mi atención al **plano telencefálico**, el esbozo telencefálico. El movimiento debe venir hacia mí. Observo una expansión.

Me posiciono en el "**Hitchman**": el movimiento gira hacia mí, se expande y asciende.

C. EL GRAN MOVIMIENTO DE ENCEFALIZACIÓN

El movimiento vuelve a partir, desciende y se expresa. Desciendo muy suavemente en la gran flexión, el gran movimiento de la **encefalización**. Recupero este movimiento a nivel occipital.

Es crucial acompañar este movimiento, no imponerlo. Se espera que se manifieste, y luego se le sigue. El movimiento ya está presente, como un "carril dibujado", con un ritmo particular. Solo se reproduce el **patrón** existente.

IV. LA COMPRENSIÓN DEL RITMO Y LA SINCRONICIDAD

Este patrón no es reproducible en el sentido de un ciclo que se repite periódicamente. Es un sistema que está constantemente ahí, una **escritura en el cuerpo**. Es la esencia misma de la **embriología biodinámica**: el esbozo de las estructuras (orejas, sistema ocular, placoda óptica, etc.) se establece según este patrón.

Añadiremos elementos a esta comprensión, pero después de haber captado esta línea directriz.

A. VINCULAR LAS ESTRUCTURAS EMERGENTES AL MOVIMIENTO

Comprender este movimiento permite ver cómo se establecen los **ventrículos**, cómo sigue la **duramadre**, cómo se forma el **cráneo**. Si algo se bloquea (un nivel que aún no conozco), puedo apoyarme en mi conocimiento del tiempo y los fenómenos sincrónicos.

Por ejemplo, puedo buscar una **arteria** o un nivel eléctrico especificado. El paciente podrá sentir lo que sucede.

B. LA IMPORTANCIA DE LA DINÁMICA CARDÍACA

Es esencial conocer bien la **dinámica** del corazón. A veces, la expansión es mayor en un lado (por ejemplo, a la izquierda).

C. EVITAR LA INTELLECTUALIZACIÓN EXCESIVA

Es importante no intelectualizar excesivamente la sensación. Una actividad mental excesiva puede "poner demasiada electricidad en el sistema límbico" y perjudicar la percepción sutil.

V. CASO PRÁCTICO: ANÁLISIS DE UNA SENSACIÓN

Durante una evaluación:

- La expansión es suave, no completa. La flexión es buena pero carece de dinamización.
- El ritmo es variable. El movimiento se inclina más hacia un carril a la izquierda, con una desaceleración.
- A veces es difícil alcanzar el **lóbulo frontal** en profundidad.

A. PROGRESIÓN DEL MOVIMIENTO

Luego, se pasa al sistema pontino, con una ascensión del tubo del paciente. Me convierto en punto de apoyo, y eso empuja. La expulsión lateral, especialmente a la derecha, comienza con más fuerza.

El paciente "recupera el paquete de abajo". Después de un inicio un poco lento, el movimiento se recupera bien.

B. EL TESTIMONIO DEL PACIENTE

El paciente describe un comienzo difícil, como si tuviera que "ponerse en marcha", soltar una fijación a la izquierda que impedía la expansión. La flexión inicial fue difícil.

Cuando se estableció una conexión, el sistema se "desbloqueó". Esto es comparable a aprender a conducir un **Fórmula 1**: al principio se es torpe, luego con el aprendizaje, funciona.

C. LAS CLAVES DEL ACOMPAÑAMIENTO

- **Entorno y espacio:** Dejar respirar, bascular el movimiento.
- **Progresividad:** Entrar progresivamente y conectarse a esta "escritura" del cuerpo.
- **Centrado de la escucha:** Centrar la escucha a nivel del cerebro, y si no "va", observar en otro lugar.

Es una cuestión de **sincronicidad**. Hay que "hacerse un sincronismo" para encontrar la palabra justa y trabajar con esta sincronicidad.